

表1 慢性好酸球性肺炎 (CEP) の診断基準

約1ヵ月以上持続する臨床症状と胸部異常陰影より CEP が疑われ、感染症などの他疾患が否定され、さらに原因の判明した好酸球性肺炎を除外した症例の中で、以下の1, 2, 3のいずれかを満たす症例を CEP とした。

1. 胸腔鏡下肺生検あるいは開胸肺生検で CEP と診断
2. 気管支肺泡洗浄液 (BALF) あるいは末梢血の好酸球が30%以上
3. a) 経気管支肺生検 (TBLB) で好酸球が多い、b) BALF の好酸球が10%以上、c) 末梢血の好酸球が6%以上
a) b) c) のうち2つ以上を満たす

[望月吉郎ほか：日呼吸会誌 40：851, 2002 より引用]

疫学・病因

CEP は1969年にCarringtonらによって提唱された、原因不明で亜急性に発症して肺局所に著明な好酸球浸潤を認める疾患である。その発症頻度は不明であるが、女性は男性に比べて約2倍の発症率があり、好発年齢は30~40歳代である。肺への好酸球集簇の機序は、BALF中でthymus-and activation-related chemokine (TARC) やRANTESが高値であることから、活性化Th2リンパ球がIL-5やeotaxinを放出し、細胞寿命の延長した好酸球の肺局所への誘導、浸潤につながっていることが示唆されている。AEPとは異なり喫煙者での発症は少ない。

症候・身体所見

臨床症状は咳嗽、発熱、喀痰、呼吸困難、体重減少、寝汗などがあるが、ときに胸痛や血痰がみられる。また、CEPの1/3に気管支喘息の合併がみられ、喘鳴を伴うことがある。アレルギー性鼻炎の合併も多い。

検査・診断

a 検査

i) 画像検査

胸部X線では非区域性で末梢優位の浸潤陰影を認め、肺水腫の陰影と対照的であることから photographic negative of pulmonary edema と呼ばれるが、このような典型的な所見を呈するのは全体の約30%である。頻度は少ないが片側性や中枢優位の浸潤陰影もみられる。その他に結節陰影や空洞陰影を呈することもあり、陰影の移動がみられることもある。AEPとは異なり胸膜病変や胸水の出現は少ない。

HRCTでは非区域性で斑状に分布する多数の胸膜直下優位のすりガラス陰影を認め、陰影の融合傾向がある。また気管支透亮像を伴う浸潤陰影も認める。

ii) 血液検査/肺機能検査

末梢血白血球数および末梢血好酸球数の増多、CRP、IgEの上昇、血沈の亢進を認める。肺機能検査

では拘束性換気障害 (%VC 低下)、拡散障害 (DLCO 低下) を認める。

iii) BALF

総細胞数と好酸球の著しい増多を認め、TARC、RANTES、IL-5、eotaxinなどのサイトカイン、ケモカインの濃度上昇を認める。しかし、BALF中の好酸球増多がみられない症例も報告され、その場合は生検による組織への好酸球浸潤増多で診断される。

iv) 病理所見

病理組織の主要所見は肺組織への好酸球浸潤と肺の既存構造の温存であり、肺腔内への好酸球や肺マクロファージの集簇と病巣部の肺泡壁や血管周囲に好酸球やリンパ球、形質細胞の浸潤がみられる。また、特徴的な病理所見として、肺腔内に集簇した好酸球が壊死を起こして肉芽腫様を呈する eosinophilic microabscess が知られているが、これは経気管支肺生検 (TBLB) で認められることは少ない。

診断と鑑別診断

CEPも統一された診断基準はないが、欧米のCordierらの診断基準⁹⁾は、2~4週以上持続する呼吸器症状を含む臨床経過と両側末梢優位の浸潤陰影またはすりガラス陰影を伴う特徴的な画像所見、BALF中好酸球比率 $\geq 40\%$ 、薬剤などの他疾患の除外を満たすことを提示しており、本邦では望月ら¹⁰⁾が表1のように診断基準を提示している。鑑別すべき疾患としては、喘息症状がある場合は好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 (EGPA) やアレルギー性気管支肺アスペルギルス症 (allergic bronchopulmonary aspergillosis: ABPA) があり、喘息症状がない場合は肺真菌症、寄生虫感染症、薬剤性肺炎、好酸球増多症候群 (hyper eosinophilic syndrome: HES)、剥離性間質性肺炎 (desquamative interstitial pneumonia: DIP)、閉塞性細気管支炎を伴う器質性肺炎/特発性器質性肺炎 [bronchiolitis obliterans organizing pneumonia (BOOP)/cryptogenic organizing pneumonia (COP)] などがある。特に、肺病変のみのHESや肺への好酸球浸潤の強いBOOP/COPは、CEPとの臨床的類似点が多いために鑑別困難であり、HESの場合は長期観察の間に認められる肺外病変の出現で、またBOOP/COPは外科的肺生検によって確定診断することがある。

治療と予後

AEPと同様にステロイド薬が著効するが、症状が軽微であれば経過観察でよい。

咳嗽や発熱があり、呼吸不全が重篤でない場合は、prednisolone 0.5~1.0 mg/kg/day で経口投与を開始し、その後漸減する。胸部陰影は約1週間で改善傾向がみられ、1ヵ月以内に消失することが多いが、副腎皮質ステロイド薬漸減中や中止後に再燃する症例が多